

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: CSSRS

1. Identificación del Instrumento

Título original	Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)
Título español	Escala Columbia para Evaluar la Gravedad del Riesgo de Suicidio
Sigla	C-SSRS
Autores originales	Kelly Posner, M. A. Oquendo et al. (Columbia University)
Año original	2008
Adaptador español	Columbia Lighthouse Project / MAPI
Año adaptación	2010
Formato	Entrevista semiestructurada o cuestionario breve de cribado

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

La C-SSRS se fundamenta en un modelo conceptual riguroso que distingue de forma precisa entre la ideación suicida (pasiva y activa) y el comportamiento suicida (intentos abortados, interrumpidos, preparatorios y tentativas completas). Es el estándar de oro recomendado por la FDA y la OMS.

3. Características Generales

Objetivo	Evaluar de forma detallada la gravedad y el curso de la ideación y conducta suicida.
Población	Niños, adolescentes, adultos y personas con disfunción cognitiva.
Administración	Entrevista clínica estructurada o cribado autoadministrado.
Tiempo	Cribado: 2 minutos; Versión completa: 5-15 minutos.
Corrección	Clasificación dicotómica (Presencia/Ausencia) e intensidad (1 a 5).

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Descripción
Ideación Suicida	1 al 5 (Gravedad de la ideación)	Evalúa el espectro desde el deseo de morir pasivo hasta el plan activo estructurado.
Intensidad de la Ideación	5 dimensiones (Frecuencia, duración, control, disuasivos, razones)	Mide el nivel de persistencia de las ideas suicidas activas.
Comportamiento Suicida	Ítems sobre intentos activos, interrumpidos, abortados y conductas preparatorias	Mide las acciones físicas llevadas a cabo por el sujeto.
Letalidad del Intento	1 ítem sobre letalidad médica objetiva y subjetiva	Determina el daño físico real o potencial del intento.

5. Sistema de Puntuación

Se registra el comportamiento dicotómico (SÍ o NO). La severidad de la ideación se puntúa en una escala del 1 (Deseo pasivo de morir) al 5 (Ideación activa con plan e intención de actuar). Se valora el marco temporal de 'último mes', 'vida entera' o 'desde última visita'.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Las respuestas afirmativas a los ítems 4 o 5 de ideación, o a cualquier ítem de comportamiento suicida reciente, indican **Riesgo Inminente o Elevado**, requiriendo una intervención de crisis o derivación inmediata a psiquiatría.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

La C-SSRS posee una excelente validez predictiva para futuros intentos de suicidio y una alta fiabilidad interjueces ($r > 0.90$), con una sensibilidad clínica cercana al 100%.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

El Columbia Lighthouse Project distribuye versiones traducidas oficialmente y validadas al español (incluidas variantes para España, Argentina, México, etc.) que cubren escalas cortas de cribado y entrevistas completas.

9. Aplicaciones Prácticas

Servicios de urgencias, psiquiatría, ensayos clínicos farmacológicos oficiales, centros escolares y penitenciarios.

10. Fortalezas del Instrumento

- Es el estándar clínico de referencia internacional para evaluar riesgo de suicidio.
- Terminología clara que evita la ambigüedad diagnóstica.
- Herramienta predictiva muy potente.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Requiere entrenamiento clínico específico para su correcta administración clínica completa.

12. Consideraciones Éticas y Legales

Toda alerta de riesgo debe ser comunicada y tratada bajo protocolos de seguridad del paciente, sin excepciones.

13. Síntesis Técnica General

La C-SSRS es la escala más completa y universal para cuantificar y predecir de forma confiable el comportamiento suicida en el ámbito de la salud.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Posner, K., et al. (2011). The Columbia-Suicide Severity Rating Scale: initial validity and internal consistency findings. *American Journal of Psychiatry*, 168(12), 1266-1277.